

Урапидил

α_1 -блокатор + агонист 5-HT_{1A} · Эбрантил / Тахибен

ФОРМА ВЫПУСКА

0,5 % · 5 мл = **25 мг**
5 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Периферия: блокада α_1 -рецепторов → расширение артериол → ↓ ОПСС. Центр: стимуляция 5-HT_{1A} → ↓ симпатического оттока → ЧСС не растёт (нет рефлекторной тахикардии). Эффект через 2–5 мин. T_½ 2,7 ч. Метаболизм печёночный.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Гипертонический криз	12,5–25 мг (2,5–5 мл)	в/в медленно
Криз, САД $\geq$ 200 мм рт. ст.	начинать с 12,5 мг (2,5 мл)	в/в медленно
Инсульт, инфаркт мозга (только САД > 200)	12,5–25 мг ; снижение $\leq$ 15 %	в/в медленно
САК / внутримозговое кровоизлияние (САД > 180)	12,5–25 мг ; снижение $\leq$ 15 %	в/в медленно
Дети до 18 лет	противопоказан (нет данных)	

Цель: снижение на 15–25 % от исходного за первый час. Не «до нормы».

НАСОС 31-Р 5 мл (25 мг) + 15 мл NaCl 0,9 % = 20 мл (**1,25 мг/мл**); 120 мл/ч → 12,5 мг за 5 мин → стоп → оценка АД → при необходимости вторая половина

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Критический аортальный / митральный стеноз — фиксированный выброс, резкое падение АД
- Гиповолемия (диуретики, рвота, этанол) — организму нечем компенсировать вазодилатацию
- Не снижает преднагрузку → не заменяет нитраты при отёке лёгких
- Горизонтальное положение обязательно (ортостатический коллапс)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Метопролол: при феохромоцитоме — сначала урапидил (α -блокада), потом β -блокатор
- Презклампися: первый — нифедипин 10 мг внутрь, не урапидил (раздел 9)
- Болюс: 25 мг до 10 мл NaCl (2,5 мг/мл). Насос: до 20 мл (1,25 мг/мл). Не путать!
- Гипертония без криза: моксонидин/каптоприл внутрь; урапидил не показан